건강보험심사평가원 HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE		보 도 자 료 http://www.hira.or.kr			
		배 포 일	2017년 8월 25일	매수	13매
		보도일시	배포즉시		
자료문의	약제관리실 약제기준부	부 장	박 영 미	02-2182-8525	
		차 장	전 미 정	02-2182-8526	
배포부서	고객홍보실 홍보부	부 장	배 영 덕	033-739-1432	
		차 장	이 성 규	02-705-6922	

키트루다주·옵디보주 급여기준 '질의 응답' 공개

- '급여 등재 전부터 허가사항 초과하여 치료받던 환자를 위한 경과 조치' 등 -

□ 건강보험심사평가원(원장 김승택, 이하 '심사평가원')은 8월 21일(월)부터 시행된 **면역관문억제제 키트루다주**(성분명: pembrolizumab), **옵디보주**(성분명: nivolumab) **급여기준에 대해 다빈도 문의사항을 중심으로 '질의 응답'**을 **공개**했다.

□ 주요 내용은 ▲급여 등재 전부터 식약처 허가사항을 초과하여 치료받고 있던 환자들을 위해 마련한 경과조치 설명 ▲급여기준에 대한 문의사항 ▲다학제적위원회가 구성된 병원에서 제출해야 하는 서식과 방법 등이다.

□ '질의 응답' 중「급여등재 전부터 식약처 허가사항을 초과하여 치료받고 있던 환자들을 위해 마련한 경과조치」를 살펴보면,

○ 다학제적위원회 구성기관이 아닌 병·의원에서 허가초과로 투여중인 환자는 연말까지 다학제적위원회 구성기관*으로 전원해야하며, 전원한 기관에서 치료가 시작되기 전에는 이전 치료기관에서 해당 약제를 투여 받을 수 있다.

※ '17년 8월 21일 기준 다학제적위원회 구성기관: '붙임'의 질문 6 참고한다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

위험할 땐 119 힘겨울 땐 129

○ 만약 8월 21일(금) 이후 허가사항을 초과하여 새로이 면역관문억제제 치료를 받고자 하는 경우에는 타 항암제의 허가초과요법*과 동일하게 다학제적위원회가 구성된 병원에서 사전승인을 받은 후 투약할 수 있다.

※ '허가초과의약품 사용 관리제도'란?

- 허가초과의약품은 임상적 근거가 충분히 확보되지 않은 약제로, 임상 현장에서 적절하게 사용되기도 하지만 때로는 임상적 유용성, 안전성 및 윤리적인 문제를 초래하기도 함.
- 이에 따라 국민의 안전한 약제 사용을 위해 허가초과약제 사용에 대한 관리제도 도입함. 특히 항암제의 경우 질병의 위중함, 약제의 독성 및 부작용 문제, 항암요법 투여주기의 지속성 등을 고려하여 2004년부터 사전승인제를 채택해오고 있으며, 다양한 분야의 전문가가 함께 참여하여 최적의 치료방법을 선택하고 안전한 약제 사용을 강화하고자 다학제적위원회가 구성된 병원에서 치료하도록 하고 있음
- '17년 6월 현재 사용되고 있는 허가초과 항암요법은 230개로, 심사평가원에서는 허가초과 약제사용의 사후 평가를 통해 근거를 생성하고 있으며 소세포폐암에 paclitaxel 요법(고식적, 2차 이상) 등 총 15개 요법에 대하여 급여(본인부담 5/100)로 전환함

□ 심사평가원 이병일 약제관리실장은 "기결정된 요법은 검토과정 없이 즉시 통보하는 등 면역관문억제제 사전 신청에서 결과통보까지 소요되는 시간을 최대한 단축하여, 국민과 요양기관 모두 안전하고 효율적인 약제사용에 혼선이 없도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

□ '질의 응답'에 대한 상세 내용은 심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr) 의료정보>의약품정보>암질환 사용약제 및 요법>FAQ에서 확인할 수 있다.

[붙임] 면역관문억제제 옵디보주, 키트루다주 급여기준 적용 관련 질의 응답 한다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

위험할 땐 119 힘겨울 땐 129

【붙임】

면역관문억제제 'nivolumab(품명:옵디보주)', 'pembrolizumab(품명:키트루다주)' 급여기준 적용 관련 질의 응답

질문 1	옵디보주(nivolumab)와 키트루다주(pembrolizumab)의 보험 적용 대상은 어떻게 되고, 내용을 어디서 확인할 수 있나요?

<답변>

○ 옵디보주와 키트루다주는 2017년 8월 21일부터 건강보험이 적용됩니다. 보험적용 대상은 PD-L1 발현율이 일정수준 이상*인 비소세포폐암 환자입니다. 구체적인 기준은 아래와 같습니다.

* 옵디보는 PD-L1 발현율 10% 이상, 키트루다는 PD-L1 발현율 50% 이상 경우

※ 이러한 급여기준은 관련 협의체, 전문가 회의와 함께 식약처 허가사항을 바탕으로 교과서, 임상진료지침, 허가 임상 문헌 등의 관련 자료를 검토하여 암질환심의위원회에서 결정되고 비용효과성 평가를 통해 만들어졌습니다.

※ **비소세포폐암 급여기준** (공고 제2017-184호, 2017.8.21 시행)

3. 고식적요법(palliative)

나. 투여단계: 2차 이상

연번	항암요법	투여대상
19	nivolumab[주1]	PD-L1 발현 양성(발현 비율 ≥ 10%[주2]) 이면서 이전 백금기반 화학요법에 실패한 stage IIIB 이상 ※ EGFR 또는 ALK 변이가 확인된 환자는 이러한 변이에 대한 승인된 치료제를 투여한 후 질병 진행이 확인되고, 이전 백금기반 화학요법에도 실패한 경우 ※ 이전 PD-1 inhibitor 치료를 받지 않은 경우에 한함.
20	pembrolizumab[주1]	PD-L1 발현 양성(발현 비율 ≥ 50%[주3]) 이면서 이전 백금기반 화학요법에 실패한 stage IIIB 이상 ※ EGFR 또는 ALK 변이가 확인된 환자는 이러한 변이에 대한 승인된 치료제를 투여한 후 질병 진행이 확인되고, 이전 백금기반 화학요법에도 실패한 경우 ※ 이전 PD-1 inhibitor 치료를 받지 않은 경우에 한함.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

위험할땐 119 힘겨울땐 129

주1. 면역관문억제제(nivolumab, pembrolizumab 등)는 예상치 못한 부작용 발생 등의 긴급 상황에 대응 가능한 의료기관에서 항암치료요법에 대한 지식과 경험이 충분한 의사에 의해 투여되어야 하며, 요양급여 실시 현황 등에 관한 자료를 건강보험심사평가원장에게 제출하여야 한다.

- 급여인정 기관: 다음에 한 가지 이상에 해당하는 기관 중 상근하는 혈액종양내과, 감염 또는 내분비내과, 병리과 전문의가 각 1인 이상인 기관
- 급여인정 기간: 1년까지(단, 질병진행시 중단) 급여인정 하되, 1년 내에 최적의 투여 기간에 대한 임상결과 미 발표 시 자동 연장하여 최대 2년으로 함.
- 투여대상: PD-L1 발현율 등의 biomarker를 활용하여 투여대상을 선정하되, 세부 암종별 특성에 따라 달리 적용할 수 있음.
- 사후관리: 요양기관에서 제출한 급여실시내역을 활용하여 효과 및 부작용에 대한 모니터링을 실시할 수 있음.

주2. IHC 28-8 pharmDx, VENTANA PD-L1(SP263) Assay 검사
주3. IHC 22C3 pharmDx 검사

○ 상기 급여기준은 건강보험심사평가원 홈페이지 www.hira.or.kr에 공개되어 있으며, 다음의 경로를 따르시면 확인하실 수 있습니다.

※ 건강보험심사평가원 홈페이지 www.hira.or.kr > 의료정보 > 의약품정보 > 암질환사용약제및 요법 > 공고 > 공고번호 제2017-184호(시행 2017.8.21.)

질문 2 비소세포폐암에 옵디보주(nivolumab), 키트루다주(pembrolizumab) 급여기준 질의사항

1)'이전 PD-1 inhibitor 치료를 받지 않은 경우에 한함.'의 의미가 무엇인가요?

<답변>

○ 'PD-1 inhitibor'는 '옵디보주, 키트루다주'를 말합니다. '이전 PD-1 inhibitor 치료를 받지 않은 경우에 한함'은 '이전에 옵디보주 또는 키트루다주를 사용한 치료를 받은 경험이 없는 환자'만 보험적용이 가능함을 의미하는 것은 아니며, 이전에 옵디보주나 키트루다주를 사용한 치료에 실패했던 환자가 다시 투여하거나, 옵디보주 투여하던 환자가 키트루다주로 변경(또는 키트루다주 투여 환자가 옵디보주로 변경)하여 투여하는 경우는 보험이 인정되지 않는 것을 의미합니다. 보험 등재시점에 급여기준에 해당하는 환자로 치료가 진행 중인 환자는 보험 등재 시점부터 보험적용 됩니다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시

위험할땐 119 힘겨울땐 129

2) 키트루다(pembrolizumab)은 현재 허가사항보다 급여기준이 왜 더 제한적인가요?

<답변>

○ 보험급여 기준은 식약처 허가사항을 기본으로 하고 있으나, 임상적 유용성 및 비용효과성이 인정되는 범위에서 정해지므로 식약처 허가사항보다 제한적으로 설정되는 경우가 있습니다.

○ 또한 키트루다(pembrolizumab)의 경우 제약사가 건강보험 적용 결정을 신청하고 평가를 진행하는 과정에서 허가사항이 확대되었습니다. 확대된 내용을 반영하기 위해서는 경제성평가 등 관련 절차를 다시 거쳐야 하므로 환자분들께 빠른 건강보험 적용 혜택을 드리기 위하여 결정신청 당시의 허가사항을 바탕으로 급여기준이 결정되었습니다.

○ 변경된 허가사항에 대한 건강보험 적용 여부 결정을 위해서는 암질환심의위원회 등의 검토가 필요하며, 향후 검토 결과에 따라 보험적용 범위는 변경될 수 있습니다.

pembrolizumab 식약처 허가사항 (비소세포폐암)	
기존 허가사항(신청 시)	현재 허가사항
▪ 효능·효과 비소세포폐암 진행성 비소세포폐암의 치료. PD-L1 발현 양성으로서, 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이후에 진행이 확인된 환자에게 투여한다. 다만 EGFR 또는 ALK 변이가 확인된 환자는 이 약을 투여하기 전에 이러한 변이에 대한 승인된 치료제를 투여한 후에도 질병의 진행이 확인된 경우여야 한다. ▪ 용법·용량 이 약을 비소세포폐암 환자에게 투여하고자 하는 경우, PD-L1 발현이 양성(발현 비율≥50%)인 비소세포폐암 환자에게만 투여 한다.	▪ 효능·효과 비소세포폐암 · PD-L1 발현 양성(발현 비율≥50%)으로서, EGFR 또는 ALK 변이가 없는 진행성 비소세포폐암환자에서의 1차 치료 · PD-L1 발현 양성(발현 비율≥1%)으로서, 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이후에 진행이 확인된 진행성 비소세포폐암의 치료. 다만 EGFR 또는 ALK 변이가 확인된 환자는 이 약을 투여하기 전에 이러한 변이에 대한 승인된 치료제를 투여한 후에도 질병의 진행이 확인된 경우여야 한다.

3) 왜 백금기반 화학요법에 실패한 경우에 한해서만 건강보험 적용이 되나요?

<답변> '백금기반 화학요법에 실패'는 두 약제의 식약처 허가사항에 명시되어 있는 내용입니다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시

위험할 땐 119 힘겨울 땐 129

※ pembrolizumab 약제의 허가사항은 위의 2)와 같으며 nivolumab의 식약처 허가사항(효능·효과)은 '이전 백금기반 화학요법에 실패한 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 치료'입니다.

4) 급여기준에 있는 PD-L1 검사는 어떻게 적용되는 것인가요?

<답변> 키트루다주(pembrolizumab)은 'IHC 22C3 pharmDx 검사'로 PD-L1 50% 이상인 경우, 옵디보주(nivolumab)은 'IHC 28-8 pharmDx 검사'나 'VENTANA PD-L1(SP263) Assay 검사'로 PD-L1 10% 이상인 경우 건강보험 적용됩니다. 이는 약제와 검사 관련 임상 문헌 및 식약처 허가사항을 바탕으로 만들어진 기준입니다.

※ pembrolizumab은 동반진단 검사인 'IHC 22C3 pharmDx 검사'로, nivolumab은 'IHC 28-8 pharmDx 검사'로 하되 최근 VENTANA PD-L1(SP263) Assay 검사가 식약처로부터 비소세포폐암에 nivolumab 약제에 대하여 PD-L1 발현을 확인할 수 있도록 허가 되어 급여기준에 이를 반영하였습니다. 또한 향후 PD-L1 검사에 대한 허가사항 변경 등이 있을 경우 급여기준에 반영될 예정입니다.

질문 3	**비소세포폐암에 옵디보주(nivolumab), 키트루다주(pembrolizumab) 단독요법이 건강보험으로 적용됨에 따라 환자 부담은 비급여일 때와 어떻게 달라지나요?**

<답변>

○ 옵디보주, 키트루다주는 2017년 8월 21일 진료분부터 건강보험이 적용됩니다. 급여기준에 정해진 조건(투여대상, 급여인정기관, 급여인정기간 등)을 모두 만족하는 비소세포폐암환자는 약값의 일부(5/100)만 부담하시게 됩니다.

○ 또한 건강보험 적용 시점(2017.8.21.) 이전부터 비급여로 치료 중이던 환자 중 급여기준을 만족하는 경우는 건강보험 적용 시점부터 본인일부부담(5/100)으로 급여가 인정됩니다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

위험할 땐 119 힘겨울 땐 129